

Faculté de Médecine « Ibn El Jazzar » de Sousse
Cycle de préparation du concours de résidanat 2025

Evaluation : Splénomégalie

Dr Zahra Kmira/Dr Ben Youssef Yosra

1- La mensuration d'une splénomégalie est appréciée :

- A- En centimètre du rebord costal gauche
- B- En travée de doigts du rebord costal
- C- En centimètre de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche
- D- A partir de la dernière cote non flottante et sur la ligne médio-claviculaire
- E- En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

2- Les caractères suivants, sauf un, sont ceux d'une splénomégalie. Lequel ?

- A - Localisée à l'hypocondre gauche
- B - Siège antérieur
- C - Mobilité à l'inspiration profonde
- D - Bord antérieur non crénelé
- E - Ne donnant pas de contact lombaire

3-Le diagnostic d'une splénomégalie repose sur:

- A- Anamnèse
- B- Examen physique
- C- Echographie abdominale
- D-Biopsie splénique
- E-Arguments biologiques

4- A propos de la splénomégalie:

- A- L'examen radiologique est indispensable pour le diagnostic de SMG
- B- L'échographie abdominale permet de confirmer le diagnostic de SMG
- C- L'échographie abdominale permet de renseigner sur l'aspect de la SMG
- D- L'échographie abdominale permet parfois d'orienter le diagnostic étiologique
- E- Une SMG est retenue par une flèche splénique supérieure à 13 cm à l'échographie

5-L'imagerie au cours d'une splénomégalie est indiquée si :

- A- Abscès splénique
- B- Candidose splénique
- C- Maladie de Gaucher
- D- Signes d'hypertension portale
- E- Lupus érythémateux systémique

6-La rate a comme rôle physiologique :

- A-destruction des globules blancs
- B-Réservoir de plaquettes
- C-Destruction des globules rouges vieilliss
- D-Production du complément
- E-Elaboration de la réponse humorale

7- Concernant la découverte de la SMG

- A – la SMG est souvent associée à des adénopathies périphériques
- B – la SMG peut être révélée par des signes digestifs
- C – la SMG peut être découverte dans un contexte de choc hémorragique
- D – la SMG est toujours associée à des anomalies de l'hémogramme
- E – la SMG peut être découverte fortuitement par un scanner abdominal

8- La circonstance de découverte d'une SMG pourrait être :

- A – une douleur de l'hypochondre droit irradiant en bretelle a l'épaule droit
- B – une anémie isolée
- C – une pancytopenie souvent modérée
- D – fortuite par un examen physique
- E – une pesanteur de l'hypochondre gauche

9- Parmi les manifestations cliniques suivantes, quelles sont celles liées à une splénomégalie ?

- A - Douleurs de l'hypocondre gauche
- B - Pesanteurs post-prandiales
- C - Epigastralgies
- D - Sensation de plénitude gastrique
- E - Peut être asymptomatique

10- Parmi les diagnostics différentiels d'une splénomégalie, vous retenez:

- A- un gros rein gauche
- B- Un kyste de la queue de pancréas
- C- Une tumeur gastrique
- D- Une tumeur de la surrénale gauche
- E- toutes les réponses sont fausses

11- les conséquences de la SMG pourraient être

- A – Des cytopénies souvent sévères
- B – Des cytopénies prédominantes sur les plaquettes
- C – Des cytopénies avec moelle pauvre
- D – Hypertension portale d'apport
- E - Hémodilution

12- Une splénomégalie peut être directement responsable:

- A – D'une thrombocytose
- B – D'une hypervolémie plasmatique
- C – D'une hémolyse intravasculaire
- D – D'une anémie microcytaire
- E – D'une neutropénie

13-Le mécanisme physiopathologique d'une SMG pourrait être :

- A- une métaplasie myéloïde
- B- Une hyperplasie splénique
- C- Une congestion par hypertension artérielle
- D- Une augmentation de la séquestration des globules rouges
- E- Un dépôt de substances ou de cellules

14- L'association splénomégalie et circulation veineuse collatérale fait évoquer

- A- une hépatite aigue
- B- une leucémie
- C- une maladie de hodgkin
- D- Une cirrhose
- E- Un syndrome de Budd Chiari

15- En faveur d'une splénomégalie infectieuse, vous retenez:

- A- fièvre et altération de l'état général
- B- Notion de contagé
- C- Syndrome inflammatoire biologique
- D- association à des adénopathies volumineuses
- E- aspect nodulaire à l'imagerie abdominale

16- Une SMG peut se voir dans la (les) infection (s) virale (s) suivante (s):

- A- la toxoplasmose
- B- la Kala Azar
- C- la rickettsiose
- D- la rubéole
- E- la mononucléose infectieuse

17- La confirmation de leishmaniose viscérale repose sur:

- A- Myélogramme
- B- PCR
- C- Sérologie de la leishmaniose
- D- Electrophorèse des protéides
- E- Hémogramme

18- Au cours d'une splénomégalie infectieuse au cours d'une leishmaniose viscérale, vous pouvez noter:

- A- fièvre anarchoïque
- B- une infection VIH associée
- C- ictère fébrile
- D- un état général conservé
- E- diarrhée

19- Une splénomégalie fébrile avec leucopénie vous évoque:

- A- une brucellose
- B- une fièvre typhoïde
- C- une candidose viscérale
- D- une mononucléose infectieuse
- E- une rickettsiose

20- L'association d'une pancytopénie sévère et d'une splénomégalie peut correspondre à l'un de ces diagnostics, lequel?

- A- Aplasie médullaire idiopathique
- B- anémie réfractaire simple
- C- leucémie aigue
- D- leucémie lymphoïde chronique au stade A
- E- Myélome multiple

21- Laquelle des hémopathies suivantes vous évoque la constatation d'une splénomégalie isolée?

- A- Maladie de Biermer
- B- Leucémie myéloïde chronique
- C- Maladie de Kahler
- D- Hémophilie
- E- Agranulocytose iatrogène

Cas clinique n°1

Enfant âgé de 3 ans admis pour une fièvre évoluant depuis 2 mois avec asthénie

A l'examen, on note une pâleur cutané-conjonctivale, une fièvre à 38,5°, une SMG volumineuse et une hépatomégalie. La NFS à 4,5 giga/l, des plaquettes à 72giga/l, une hémoglobine à 4,83g/dl. La VS à 81 mm à la première heure). La protidémie à 85g/l. l'électrophorèse des protéines sériques montre une albumine diminuée et hypergammaglobulinémie, la recherche d'anticorps anti-leishmania est positive. Le myélogramme montre de nombreux amastigotes de leishmanies.

1- Les données cliniques faisant évoquer la leishmaniose viscérale sont:

- A- l'âge inférieur à 5 ans
- B- Les diarrhées
- C- La triade: fièvre, pâleur et splénomégalie
- D- Le caractère douloureux de la splénomégalie
- E- Le caractère irrégulier de la fièvre

2- Les données biologiques faisant évoquer la leishmaniose chez cet enfant sont:

- A- le syndrome inflammatoire biologique
- B- le taux de leucocytes
- C- le caractère polyclonal de l'hypergammaglobulinémie
- D- La pancytopénie
- E- L'hypoalbuminémie

3- Les arguments confirmant le diagnostic parasitologique de leishmaniose sont:

- A- la mise en évidence des corps de leishmanies sur myélogramme
- B- la PCR positive sur moelle osseuse
- C- la présence d'anticorps sériques anti-leishmania
- D- L'hémoculture
- E- La culture positive du prélèvement médullaire sur milieu spécifique

Cas clinique n°2

Aux urgences pédiatriques, vous trouvez un enfant de 3 ans, issu d'un mariage consanguin, ramené par sa maman pour asthénie croissante avec abdomen ballonné. L'examen montre une pâleur cutanéomuqueuse, un ictère ainsi qu'une énorme splénomégalie arrivant à l'ombilic, NFS: GB: 10000/mm³ (PNN 7000/mm³, lymphocytes: 1900/mm³, Hb: 6g/dl, VGM: 60fl, rétic 150000/mm³, plaquettes 355000/mm³, frottis : cellules cibles, LDH 480 (N= 205UI/l), Bil: 80 mmol/l (n=20 mmol/l), bil D=4 mmol/l (n<5mmol/l). Haptoglobine 0,15 (N=0,25-1,8)

•

1- Quel est le mécanisme de cette SMG

- A- Hyperplasie splénique
- B- augmentation de la pression dans le système porte
- C- infiltration tumorale
- D- surcharge métabolique
- E- métaplasie myéloïde

2- Une anémie hémolytique est diagnostiquée, concernant ce diagnostic ces affirmations sont justes:

- A- le tableau est celui d'une hémolyse intravasculaire
- B- le tableau est celui d'une hémolyse extravasculaire
- C- l'hémolyse est constitutionnelle
- D- l'hémolyse est corpusculaire
- E- l'hémolyse est extracorporelle

3- Quel est le diagnostic le plus probable?

- A- Déficit en G6PD
- B- Déficit en pyruvate kinase
- C- Maladie de Cooley
- D- Drépanocytose
- E- Sphérocytose héréditaire

Cas clinique n°3

Mme L A âgée de 35 ans sans antécédents pathologiques, présente depuis 2 mois un amaigrissement chiffré à 3 kg, une fièvre oscillante entre 38° et 39°. L'examen clinique est normal en dehors d'une masse de l'hypochondre gauche

1- A quoi peut correspondre cette masse:

- A- une tumeur de la queue de pancréas
- B- un gros rein gauche
- C- une tumeur de l'angle colique gauche
- D- une splénomégalie
- E- une tumeur gastrique

2- Quels examens demandez-vous de 1ère intention afin de confirmer la nature de cette masse:

- A- ASP
- B- un lavement baryté
- C- une échographie abdominale
- D- un scanner abdominal
- E- une IRM abdominale

On a complété les investigations par une NFS GB: 3200/mm³ Hb 8g/dl avec un VGM à 80fl plaquettes 90000/mm³. L'examen radiologique abdominal demandé a objectivé la présence d'adénopathies profondes ainsi qu'une rate à 19 cm de grand axe homogène,

3- quelles sont vos hypothèses diagnostiques:

- A- tuberculose des organes hématopoïétiques
- B- hépatite virale aigue
- C- lymphome
- D- leishmaniose viscérale
- E- LAM

4- Parmi ces examens, quels sont ceux qui sont les plus pertinents à réaliser en 1ère intention afin de confirmer le diagnostic

- A- recherche de BK dans les crachats
- B- ponction biopsie ganglionnaire scannographique
- C- myélogramme
- D- sérologie de leishmaniose
- E- splénectomie diagnostique